

Diverticulite aguda · Hinchey e conduta

Diverticulite esquerda no idoso é clássica. TC classifica complicação; não complicada pode ser conservadora, abscesso pode drenar e peritonite vai à cirurgia.

Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

TC com contraste é o exame de escolha na suspeita. Colonoscopia não na fase aguda — agende após resolução para excluir neoplasia.

Escale terapia conforme imagem e status sistêmico — Hinchey orienta a prova.

Diverticulite por gravidade

Não complicada / abscesso / peritonite

Não complicada

Dor FIE + inflamação
ATB +/- ambulatorio
Dieta e analgesia

Maioria

Abscesso

Coleção localizada
ATB + drenagem se >3-5 cm
Cirurgia se falha

Hinchey I-II

Peritonite

Furada com difusão
Ressuscitação + ATB
Cirurgia urgência

Hinchey III-IV

Pontos de conduta

- Não complicada selecionada: manejo conservador; ATB nem sempre obrigatório em imunocompetentes leves (fique atento ao que a banca adota)
- Abscesso: drenagem percutânea quando acessível e tamanho significativo
- Cirurgia de urgência: Hartmann ou anastomose primária conforme estabilidade e contaminação
- Recorrências frequentes / complicações: eletiva individualizada

Hinchey (resumo)

Grau | Achado

0 / I | Flegmão / abscesso pericólico

II | Abscesso pélvico / distante

III | Peritonite purulenta

IV | Peritonite fecal

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não faça colonoscopia na diverticulite aguda — risco de perfuração. Primeiro episódio 'típico' no jovem ou alarm signals: exclua outras causas e programe avaliação colônica após.